

II

현황과 문제점

○ (수요) 고령자를 위한 주거개조 지원 및 재가급여 확대에도 불구하고, ① 장기요양보험의 시설급여를 받을 수 없는 경증요양자, ② 장기요양 미인정 후기고령자, 그리고 ③ 1인 고령가구를 중심으로 돌봄과 주거가 통합된 주거유형에 대한 관심이 커질 것으로 예상됨

- 현재 장기요양보험제도 내에서 경증요양자의 시설급여 의존도가 높게 나타나며, 이는 경증요양자를 중심으로 주거와 돌봄이 결합된 주거모델에 대한 수요가 클 것임을 시사함
 - 장기요양보험제도상 요양시설은 중증 수급자인 1·2등급 고령자를 대상으로 설계되었으나, 3~5등급 수급자 중에서도 가족의 수발이 어렵거나, 주거환경이 부적절하거나, 치매로 인한 문제행동으로 인해 재가급여 이용이 사실상 불가능한 경우에는 시설급여가 예외적으로 인정됨
 - 실제로 시설급여 이용자의 69%가 3·4등급 수급자이며, 3등급의 38%, 4등급의 20%가 시설급여를 이용함(그림 II-1) 참조)
 - 현재의 연령대별 장기요양 인정자 비율이 유지된다고 가정할 경우, 65세 이상 경증요양자(3~5등급 및 인지지원등급)는 2023년 92만 명에서 2050년에는 283만 명으로 증가할 것으로 전망됨(표 II-1) 참조)
- 신체 및 인지 기능의 저하가 요양등급을 받을 정도에는 이르지 않았더라도, 후기고령자는 일상생활 기능의 점진적인 저하로 인해 독립적인 생활에 불안을 느끼며 일정 수준의 지원 및 돌봄을 필요로 함
 - 현재의 연령대별 장기요양 인정자 비율이 유지된다고 가정할 경우, 85세 이상 인구 중 장기요양 미인정자는 2023년 60만 명에서 2050년에는 243만 명으로 증가할 것으로 예상됨(표 II-1) 참조)
- 후기고령자 중 1인 가구는 장기요양 재가급여 수급 여부와 관계없이 지원과 돌봄 공백에 대한 불안이 존재하며, 85세 이상 1인 가구는 2023년 26만 가구에서 2050년 141만 가구로 증가할 것으로 전망됨
- 보건복지부의 2023년도 노인실태조사에 따르면, 건강 악화 시 희망 거주 형태로 '노인전용주택'을 선택한 응답 비율이 16.5%로 나타났으며, 이는 우리 사회에서 서비스제공주택의 개념이 아직 구체화되지 않은 상황임을 고려할 때 비교적 높은 수치임
 - 연령대별로는 65~69세 19.9%, 70~74세 17.1%, 75~79세 16.7%, 80~84세 10.6%, 85세 이상 11%로, 연령이 낮을수록 노인전용주택 거주를 희망하는 응답자의 비율이 증가함

〈그림 II-1〉 장기요양등급별 시설급여 이용 현황

(단위: %)



주: 요양등급별, 시설유형별 중복을 허용함

자료: 국민건강보험공단, 노인장기요양보험통계연보(2023년)

〈표 II-1〉 장기요양등급 상태별 고령자 분포

(단위: 천 명)

구분	2023년			2050년		
	1·2등급	3~5등급, 인지기원등급	장기요양 미인정자	1·2등급	3~5등급, 인지기원등급	장기요양 미인정자
65~74세	23	137	5,349	32	198	7,145
75~84세	56	422	2,471	140	1,056	6,057
85세 이상	20	359	599	281	1,573	2,427
계	98	919	8,418	453	2,827	15,628

주: 2023년 연령대별(5세 단위)·요양등급별 장기요양등급 인정비율이 유지된다고 가정함

자료: 국민건강보험공단, 노인장기요양보험통계연보(2023년); 통계청, 장래인구추계(2022년)

○ (공급) 급속한 고령화와 고령인구의 지속적 증가를 고려할 때, 서비스제공주택의 공급 규모는 제한적이며, 향후 수요를 충족하기에는 현저히 미흡한 수준임

- 고령자를 위한 서비스제공주택에는 ‘노인복지법’에 따른 노인주거복지시설인 노인복지주택, 양로시설, 노인공동생활가정과, ‘공공주택특별법 시행규칙’에 근거하여 공급되는 고령자복지주택이 포함됨
 - 국토교통부가 2024년 도입하겠다고 발표한 실버스테이 역시 서비스제공주택에 해당함
- 고령자복지주택이 지자체에 의해 운영되고, 양로시설 및 노인공동생활가정이 비영리단체 중심으로 저소득층을 대상으로 한 공공성이 강한 구조인 반면, 노인복지주택은 영리법인이 주도하는 민간 중심의 시장으로 형성됨(〈표 II-2〉 참조)
- 노인복지주택은 2023년 기준 40개소(정원 9,006명), 양로시설 및 노인공동생활가정은 2022년 기준 총 269개소(정원 10,515명)이며, 후자의 경우 시설 수, 입소정원, 입소율 모두 감소세를 보임(〈표 II-3〉 참조)
 - 고령자복지주택은 3,956세대에 불과함
- 무엇보다도, 서울·경기 지역에 위치한 노인복지주택의 월 이용료는 국민연금(노령연금) 30년 이상 가입 수급자의 월평균 지급액(2014년 1월 기준 157만 원)을 크게 초과함
 - 송파 위례 심포니아의 경우, 월세형은 입소 보증금 4억 9,500~5억 8,500만 원이며, 임대료, 생활비, 식대를 포함한 월 이용료는 1인 기준 310~360만 원임

〈표 II-2〉 고령자를 위한 서비스제공주택 현황

구분	노인주거복지시설			고령자복지주택
	노인복지주택	양로시설	노인공동생활가정	
법적 근거	「노인복지법」			「공공주택특별법 시행규칙」
입소대상자	60세 이상 단독취사 등 독립생활 가능자	일상생활에 지장이 없는 노인으로 ① 65세 이상 기초생활수급자 등 ② 65세 이상 저소득자 ③ 60세 이상 전액 본인부담자		65세 이상 무주택세대 구성원으로 생계급여수급자 또는 의료급여수급자 등 취약계층 고령자
주요 서비스	주거의 편의, 생활지도, 상담 및 안전관리 등 일상생활에 필요한 편의	급식과 일상생활에 필요한 편의	가정과 같은 주거여건, 급식, 일상생활편의	급식, 사회복지시설, 보건서비스
비용 부담	전액 본인부담	① 공공 전액부담 ② 공공 일부부담 ③ 전액 본인부담		-
정원	30세대 이상	10인 이상	5~9인	-
주거방식	임대차계약	당사자 간 계약		공공 임대
2023년 기준 공급 현황 및 공급자	영리·비영리 - 주식회사 47.5% - 40개소(9,006세대)	비영리법인과 개인(주식회사 1개) - 양로시설: 175개소(9,653명) - 노인공동생활가정: 82개소(710명)		공공 공급 - 3,956세대(지자체+LH)

자료: 노인복지법; 공공주택특별법 시행규칙; 보건복지부, 노인복지시설 현황(2023년)

〈표 II-3〉 노인주거복지시설 공급 현황(2018~2022년)

(단위: 개소, 명, 세대)

구분	시설 수					입소정원				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
양로시설	238	232	209	197	180	12,510	13,036	11,619	9,962	9,752
노인공동생활가정	117	115	107	107	89	998	954	953	930	763
노인복지주택	35	35	36	38	39	6,389	7,684	7,925	8,491	8,840

자료: 보건복지부, 노인복지시설 현황, 각 연도

○ (시장) 중산층 자립가능 고령자 또는 경증요양이 필요한 고령자를 위한 서비스제공주택의 공급이 부족함

- 저소득층의 경우 양로시설, 노인공동생활가정, 또는 고령자복지주택을 이용할 수 있고 고소득층은 민간 주도의 고급 유료 양로시설이나 노인복지주택을 선택할 수 있는 재정적 여력이 있음
 - 돌봄필요도가 높은 장기요양 1·2등급 인정자는 경제력에 상관없이 노인요양시설 입소가 가능함
- 돌봄필요도가 상대적으로 낮은 3~5등급 또는 인지기원등급 인정자의 경우 시설 입소보다는 재가돌봄을 우선적으로 이용하도록 유도되고 있으나 재가급여으로는 돌봄 공백이 발생함
- 이와 같은 상황에서 서비스제공주택과 같은 중간 단계의 돌봄주거모델이 부족할 경우, 3~5등급 또는 인지기원등급 수급자는 적절한 주거 및 돌봄 지원을 받기 어려운 문제에 직면함

- 예외적으로 장기요양 3~5등급의 경증요양자도 장기요양시설을 이용할 수 있으나, 고령화가 가속화됨에 따라 후기 고령인구의 증가와 함께 중증 요양자의 비율이 점차 높아질 것으로 예상되므로, 장기요양시설을 경증요양자를 위한 거주형 시설로 간주하기에는 한계가 있음

○ (문제점) 중산층 고령자를 위한 서비스제공주택 시장은 자율적으로 형성되기 어려운 특성을 지님

- 공급자 관점에서, 서비스제공주택은 일반주택에 비해 개발비용이 크고, 자금조달의 어려움, 판매속도의 지연, 장기적인 투자 회수 기간, 자산의 낮은 유동성과 재판매 가치, 적합 부지 확보의 어려움 등 다수의 제약요인이 존재함
 - 서비스제공주택은 고령 친화적 설계와 공용공간(식당, 활동실, 간호사 스테이션 등) 등으로 인해 일반주택에 비해 건설비용이 높고, 유동성이 낮아 재판매 시장에서 가치 하락 가능성이 존재하며, 이는 투자 회수의 불확실성을 증대시키는 요인으로 작용함
 - 서비스 제공을 기반으로 하는 운영 모델의 특성상 입주율이 100%에 미치지 않더라도 일정 수준 이상의 인력과 서비스를 유지해야 하므로, 운영 초기에는 높은 고정비가 발생함
 - 서비스제공주택은 주거공간과 더불어 지속적인 비용이 수반되는 서비스가 포함되어 있어 소비자가 일반주택에 비해 신중하게 의사결정을 내리는 경향이 있으며, 이로 인해 판매 속도가 느리고 초기 투자비 회수가 지연되는 구조적 특성을 가짐
 - 도시 거주를 기반으로 한 AIP(Aging in Place) 수요는 증가하고 있으나, 개발이 이미 포화 상태에 이르고 고령자 주거시설에 대한 지역사회의 수용성도 낮아, 적절한 부지를 확보하는 데 어려움이 있음
- 아울러 서비스제공주택은 지속적인 서비스 제공이 전제된 주거 형태로서 장기적인 운영전략과 수익구조의 다변화가 필수적이거나, 현행 수익구조는 임대료와 서비스비에 전적으로 의존하는 실정임
 - 운영사업자의 수입원이 식비, 임대료 및 관리비, 서비스비 등으로 한정된 상황에서, 수익성을 확보하기 위해 고급화 전략에 집중할 수밖에 없으며, 이로 인해 서비스제공주택은 자연스럽게 고소득층을 중심으로 공급되고, 중산층을 포괄하는 주거 대안으로 기능하기 어려움
- 소비자인 고령자 관점에서, 서비스제공주택은 일반주택 대비 높은 월 이용료와 지속적인 비용 부담이라는 경제적 제약과 함께, 향후 요양 및 의료적 필요에 대한 대응력이 제한적이라는 우려가 존재함
 - 서비스제공주택은 일반주택과 달리 돌봄 및 생활지원 등 맞춤형 서비스를 포함함으로써 주거의 기능을 확장하지만, 이는 높은 운영비용을 초래하여 거주자에게 장기적인 경제적 부담을 줌
 - 노인복지주택에 입주한 장기요양 인정자는 외부 사업자와 개별 계약을 통해 재가급여를 이용해야 하나, 재가급여는 수시로 발생하는 돌봄 요구에 즉각적으로 대응하기 어려움